

INDICADO POR: Dr. Guel

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

LUIS CLAUDIO SANCHES

IDADE: 54 PESO: 125 ALTURA: 1,76 PROFISSÃO: Gerente Comercial

SINTOMAS: Acorda Comado; Falta de sono; tontura pela manhã

QUEIXAS: Ronco; Acorda c/ Engasgos e falta de ar; Sonolência diurna

MEDICAMENTOS: HAS + Colestural + DM.

Gestão - reflexo?

MÉDICO: Dr. Guel - Cardio

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhada diária

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h HORA QUE ACORDA: 05h / 06h

COCHILHO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N FDS OKFUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: há 55 anos parou

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: IV

IAH: 5 e 1h SPO2: 81% A na: 90%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

b N3: 4%

b REM: 4%

CIRURGIAS: ☒ NASAL () AMIGDALECTOMIA Rino plastia há 30 anos. despendeu 31 e 1h

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N

SPO2 C/ CPAP: —

PRESSÃO NO EXAME: —

TC seio face: Desvio septo à D + espessamento epitelial
hipertrofia concha nasal D.
hipertrofia tonsilas palatinas

24/06/2025

27/06/2025 Avaliação Auto 4 a 12 cm H₂O.

marc P30i (M).

perdeu 14 Kg em 3 meses

Sicilia

12/07/25 P = 9,8 cm H₂O (med) / Pico: 11,3 cm H₂O

IAH = 3,6 e 1h

m de ure: 4 e 17'

freq: 11,3 e 11m

Relata crise de gastrite

está aguardando endoscopia

e está qüipando

55 d ure 12 d

6 e 4h

Natacha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LUIZ CLAUDIO SANCHES			
Sexo: M	Idade: 53 anos	Peso: 125 Kg	Altura: 1.75 m
IMC: 40.8	Data do Exame: 09/06/2025	Exame: 00642_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:38:22 PM horas e encerrado às 6:00:53 AM horas, com latência para o sono de 17 minutos e latência para o sono REM de 306 minutos. O tempo total de sono foi de 412.0 minutos, com eficiência do sono de 92.6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.7%	Até 5%
Estágio 2	90.3%	45 - 55%
Estágio 3	4.4%	> 15%
Sono REM	4.6%	20 - 25%
Eficiência do sono	92.6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 15.5 minutos ocorreram **216 despertares (índice de 31.5 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 76 bpm, a maior de 98 bpm e a menor de 64 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 352 eventos respiratórios, sendo 0 central e 352 obstrutivos. Sendo 348 apnéias, 4 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 51.3/hora**, sendo 50.7 apnéia/hora e 0.6 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 21.1 e a duração máxima de 37.1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 69.5/hora, sendo 69.5 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 90%, a maior de 97% e a mínima de 81%, permanecendo 122.5 minutos (27.5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 352 dessaturações. Índice de dessaturações: 51.1/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 35.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 52.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264

PLANI

Medicina Diagnóstica

Nome:
Solicitante:
Prontuário:

LUIS CLAUDIO SANCHES

Dr(a): **GISEL PEREIRA CALDAS JUNIOR**

525734

Atendimento: 021 - 0596625

Data: 24/06/2025

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE DOS SEIOS DA FACE

TÉCNICA:

A presente avaliação foi realizada em aparelho tomográfico de multidetectores, sem a injeção de contraste iodado, através de aquisição sequencial e volumétrica no plano axial. As imagens adquiridas foram pós-processadas com reconstruções multiplanares e tridimensionais, com técnica de máxima intensidade de projeção e Volume Rendering. Foram empregados parâmetros de redução de dose.

ANÁLISE:

Transparência habitual das cavidades aéreas paranasais.
Desvio do septo nasal de convexidade para a direita, associado a pequeno esporão ipsilateral.
Leve hipertrofia da concha nasal inferior direita.
Unidades ostiomeatais, meatos médios e inferiores livres.
Recessos esfenotmoidais e ductos frontonasais sem alterações significativas.
Ductos nasolacrimais de aspectos tomográfico habitual.
Ausência de lesões osteoblásticas e osteolíticas envolvendo as porções ósseas focalizadas.
Rinofaringe de aspecto habitual.
Leve irregularidade e hipertrofia das tonsilas palatinas.
Fossas de Rosenmüller sem evidência de alterações significativas.
Fossas pterigopalatinas de dimensões preservadas.
Como variações anatômicas observamos pequeno óstio acessório de drenagem com aspecto patente a parede medial do seio maxilar esquerdo e pneumatização da clinoide anterior direita.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Desvio do septo nasal de convexidade para a direita, associado a pequeno esporão ipsilateral.
Leve hipertrofia da concha nasal inferior direita.
Leve irregularidade e hipertrofia das tonsilas palatinas.

DR. MURILO FERNANDES DA SILVA CRM- 100586

Faça também seus exames de sangue e laboratoriais conosco.
Rua Paraibuna, 811 - Jardim São Dimas, São José dos Campos-SP, 12245-020 - Telefone: (12) 3797-5411



CENTRO DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA ANDRÔMEDA
DR GISEL PEREIRA CALDAS JUNIOR
TITULAR EM CARDIOLOGIA - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA
RQE - REGISTRO QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA - 19.739
CRM-SP- 49.112

S J CAMPOS, 24 DE JUNHO DE 2025

LUIS CLAUDIO SANCHES

SONOFISIO

AValiação PARA USO DE CPAP

R. Santa Elza, 418

TEL 3921.1001

DR GISEL CALDAS JR
CARDIOLOGISTA
CRM-SP-49.112
RQE 19.739

27/6/2025

✓

AS 11:00HS

ESPAÇO ANDROMEDA SHOPPING – AV ANDRÔMEDA 693 CJ 501-503 T.39330063